



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : كميليا عبده محمود عبدالحاميد

العنوان : البدرشين

الحي / المدينة : البدرشين

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 01-10-2026

رقم البطاقة : 26810292100906 رقم التليفون : 01145940939

العمر (تاريخ الميلاد) : 29-10-1968 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي : (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه : (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان الرئة

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان الرئة

خطة العلاج : جراحات أورام منظار + عينه [10435] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: كميليا عبده محمود عبد الحميد National ID: 26810292100906	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of lung cancer for Endoscopy with biopsy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



كميليا
عبد محمد عبد الحميد
قرية ابوصير
مركز البدرشين - الجيزة



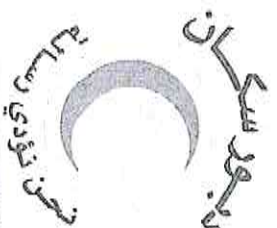
٢٦٨ ١٠ ٢٩ ٢١ ٠٠٩ ٠٢

KM7207619

[[DOC RE-ID FRONT]]
National ID - Front

face network

رئيسين ومخاطب مسي مفتوح - مغلق
جهاز مراقبة طبية متحدث الشمرات
موجات صوتية قلب أطفال وكهرباء - دولبر ولون
ماموجرام عالي التردد - باوراما الأسنان ديجيتال
رسم مسح - شدة مسة مغناطيسية مقومة
معدن ال تخاليل طبر
رسم عصب وعظام - سونار رياضي الأبحاث
4.D جهاز ال



مركز دبور للتشخيص الطبي
د/ أحمد أنور دبور
استشاري الأشعة التشخيصية
رئيس قسم الأشعة بالمستشفى العام
معهد ناصر ٢٠٠٦ - ٢٠٠٠

Name	Kamilia Abdo Mahmoud	DATE	31	07	2026
Physician	PROF.DR: El Shima Mohamed				

MRI EXAMINATION OF THE LUMBO-SACRAL SPINE

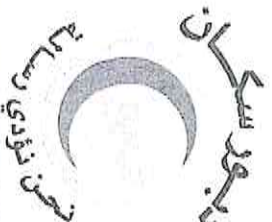
Technique:

- Sagittal T1 & T2 WIs
- Axial T2 WIs

Findings:

- Straightening of normal lumbar lordosis
- D12 vertebral body minimal focal compression of its upper and lower vertebral end plates.
- L3 & L5 right vertebral pedicles focal sclerotic bony lesions for clinico-laboratory and radiological assessment.
- Preserved sagittal diameter of the bony lumbar spinal canal
- Lumbar spondylodegenerative changes manifested by :-
 - Antero & posterolateral marginal osteophytic lipping of the vertebral end plates
 - Subchondral degenerative marrow changes of vertebral end plates
 - Diminished height and bright T2 signal intensity of the lumbar discs denoting their degeneration.
 - Global bilateral facet joints arthrosis.
 - L3-4, L4-5 & L5-S1 diffuse posterior disc protrusions osteophyte complexes with mild right side inclination indenting the theca augmented by mildly hypertrophied opposing ligamenta flava and exerting bilateral foraminal neural compromise more upon right side augmented by hypertrophic arthropathy of corresponding facet joints
- Diffuse osteoporotic bony texture.
- Normal MRI of conus medullaris and proximal cauda equine nerve roots.
- No pre-vertebral or para-vertebral signal abnormalities.

رئيس مستشفى مدني مفتوح - مفتاح
 جهاز مقبضية مفتوح - مفتاح
 موجات صوتية قلب، أحبال وكبار وبلر ملون
 ماموجام علي الشدي بانوارها الأسعان ديجيتال
 رسم مـخ - فـد مـة مغناطيسية مغناطيسية
 معمل ل تحاليل طرية
 رسم عصب وعشالات - مدونار رياضي الأبحاث
 جهاز ال
 4.D



مركز دبور للتشخيص الطبي
 د / أحمد أنور دبور
 استشاري الأشعة التشخيصية
 رئيس قسم الأشعة بالمستشفى العام
 معمل فاصل ٢٠٠٠ - ٢٠٠٦

Name	Kamila Abdo Mahmoud	DATE	31	07	2026
Physician	PROF.DR:El Shima Mohamed				

MRI EXAMINATION OF THE CERVICAL SPINE

Technique:

- Sagittal T1 & T2 WIs
- Axial T2 TSE & FFE WIs

Findings:

- Cervical spondylodegenerative changes in terms of:
 - Atlanto-axial hypertrophic arthrosis.
 - Antero and posterolateral marginal osteophytosis of opposing end plates
 - Reduced hydration of all cervical discs.
 - Global apophysal joints arthrosis.
- C2-3, C3-4, C4-5 & C5-6 posterior central disc protrusions osteophyte complexes with mild left side inclination indenting the opposing ventral cord aspect slightly encroaches upon corresponding left lateral neural exit foramina.
- C6-7 posterior central disc protrusion osteophyte complex with mild right side inclination indenting the opposing ventral cord aspect slightly encroaches upon corresponding right lateral neural exit foramina.
- Normal MRI appearance of the cervical cord & cranio-cervical junction
- Rather osteoporotic bony texture.
- No cervical paraspinal signal abnormalities.

Conclusion:

- Cervical spondylodegenerative changes
- Global apophysal joints arthrosis.
- C2-3, C3-4, C4-5 & C5-6 mild posterior central disc protrusions osteophyte complexes with mild left side inclination indenting the opposing ventral cord aspect slightly encroaches upon corresponding left lateral neural exit foramina.
- C6-7 mild posterior central disc protrusion osteophyte complex with mild right side inclination indenting the opposing ventral cord aspect slightly encroaches upon corresponding right lateral neural exit foramina.
- Rather osteoporotic bony texture.

Best Regards,

Dr. Ahmed Anwar Dabbour
 Radiology consultant

Best Regards,

Dr. Yasser A. A. Fattah MD
 Radiology Consultant

Pat. Name: Kamilia Abdou Mahmoud Abdel Hameed	Pat. ID: 10210363
Pat. Age 59 Y(s)	Pat. Sex F
Study ID: 18387	Study End Date: 21/09/2026 09:15:00
Procedure Name: PET-CT	Ref. Phy. شريف جلال

¹⁸F-FDG PET/CT examination

Clinical history: Patient with history of brain metastasis of unknown primary, referred for assessment.

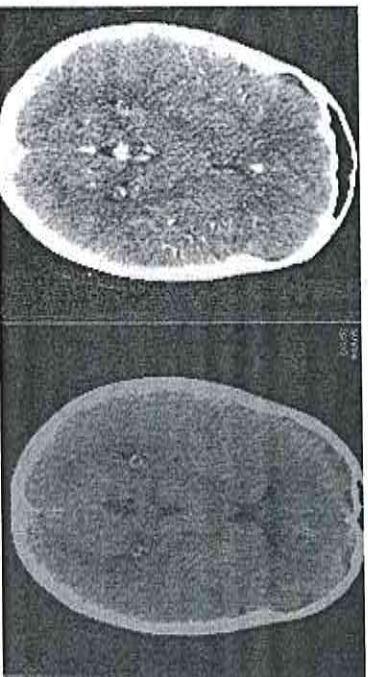
Dose was injected according to body weight.

Procedure:

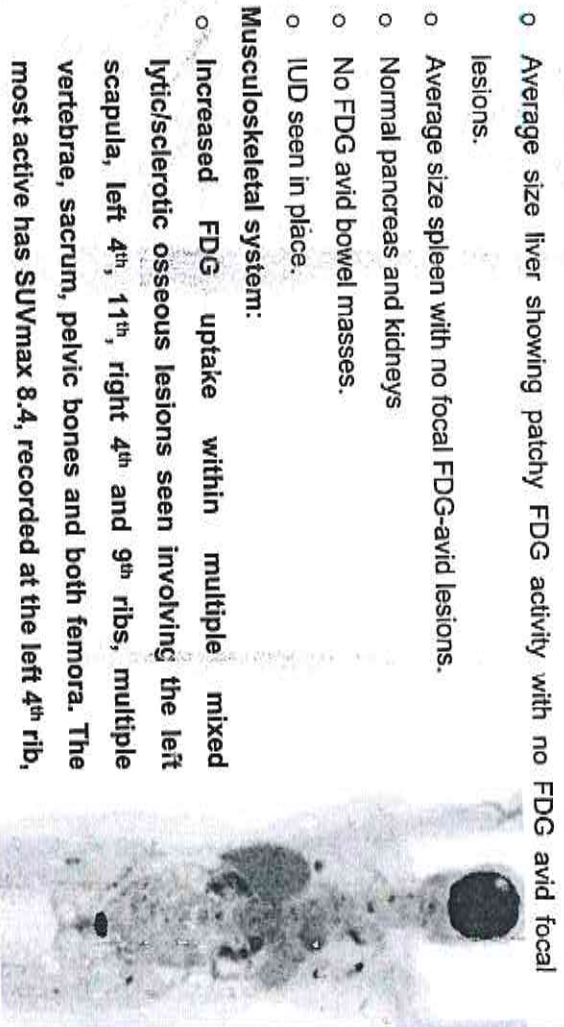
- Prior to administration of the radiotracer, blood glucose level was 106 mg/dl.
- CT images with contrast for attenuation and localization followed by PET images from the skull vertex to mid-thigh were obtained.
- Hepatic SUVmax reference ~ 4.5

Findings:

- Head and Neck region:
 - Low grade FDG uptake by bilateral small cerebral focal lesions, with SUVmax 8.8 " similar to background brain activity" and measures 1.2 cm in the left parietal lobe.



- No FDG-avid focal lesions at nasopharynx, oropharynx or larynx.
- No FDG-avid cervical lymph nodes.
- Normal thyroid gland with no focal FDG uptake.
- Normal FDG uptake within the salivary glands.



- Average size liver showing patchy FDG activity with no FDG avid focal lesions.
- Average size spleen with no focal FDG-avid lesions.
- Normal pancreas and kidneys
- No FDG avid bowel masses.
- IUD seen in place.
- Musculoskeletal system:
 - Increased FDG uptake within multiple mixed lytic/sclerotic osseous lesions seen involving the left scapula, left 4th, 11th, right 4th and 9th ribs, multiple vertebrae, sacrum, pelvic bones and both femora. The most active has SUVmax 8.4, recorded at the left 4th rib, associated with extra-osseous/pleural-based soft tissue nodule.
 - Spondylo-degenerative changes of the spine.



OPINION:

***** PET/CT study reveals:**

- Metabolically active spiculated left upper lung soft tissue mass, likely neoplastic for histopathological correlation.
- Metabolically active brain, bilateral adrenal and osseous lesions, likely metastatic.

Radiologist

Dr. Amr Abd Elfattah, MD

Nuclear Medicine physicians

Dr. Ayia Mustafa Mussa, MD

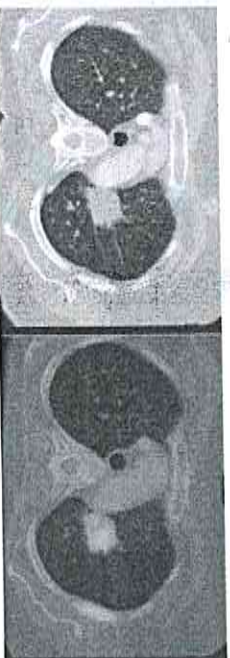
Dr. Nafila Dessoki, MD

- **Mediastinum:**

- **Low grade FDG uptake within small mediastinal pre-vascular, pre-caval, pre-tracheal and subcarinal lymph nodes.** The former has SUVmax 1.9 and measures ~ 1 cm.
- Clear both breasts and axillae with no FDG avid lesions.
- Normal myocardial increased FDG activity.
- Normal appearance of trachea-bronchial tree as well as the esophagus.
- Normal appearance of mediastinal vasculature.

- **Lungs and pleurae:**

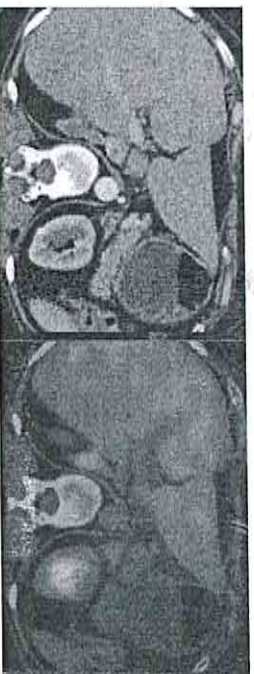
- **Increased FDG uptake within spiculated soft tissue mass seen located in the para-mediastinum and resting over the oblique fissure in the left upper lung lobe, with SUVmax 6.1 and measuring ~4.5 x 2.8 cm.**
- Radiating perilesional atelectatic bands and tiny internal calcific foci noted as well.



- No other FDG avid pulmonary nodules.
- Bilateral basal atelectatic bands.

- **Abdomen and pelvis:**

- **Increased FDG uptake within multiple bilateral adrenal nodular lesions, the most active recording SUVmax 5.2 and measuring ~1.7 cm in the right side.**



- **Low grade FDG uptake by abdominal peri-caval and left para-aortic LNs.** The latter has SUVmax 2.0 and measures ~1 cm.
- No FDG avid or enlarged pelvic lymph nodes.